伊甸汐止小作所｜教保員・社工 專業研習講義

身心障礙者預防及延緩失能的活動設計

運動 × 認知 × 生活功能：讓每一位學員都「動得到、想得到、用得到」

10/24（六）13:30–16:30　講師：鍾孟修 職能治療師（愛迪樂）　對象：教保員、社工

本講義重點

1. **核心訓練模組**：有氧、肌力、平衡、體智能怎麼練？怎麼「簡化」與「逐步加難」？
2. **功能性訓練**：什麼是運動的功能性、認知的功能性？與單純的認知訓練、認知刺激有什麼不同？
3. **慢性病與健康**：為什麼小作所學員更需要運動？規律飲食與「抑制功能」的關係。
4. **教案設計**：懷舊教案的「連結已知 × 深度運作」，功能性認知的「配對・組合・排序・線索」，以及八大功能性動作。
5. **現場應用**：團體差異這麼大，如何同一個活動、不同層次參與？個別活動又怎麼規劃？

使用方式：本講義是網頁版，**藍色／橘色的膠囊按鈕都可以點**，直接開啟遊戲、影片與資料庫，研習中我們會邊講邊操作。右下角按鈕可列印成 A4 紙本。

課程流程

13:30–13:45	開場暖身（節奏遊戲）＋ 先認識我們的學員
13:45–14:25	單元一　核心訓練模組（實作：有氧步伐、坐站、平衡、體智分級）
14:25–14:50	單元二　功能性訓練解析（運動的功能性 vs 認知的功能性）
14:50–15:00	休息
15:00–15:15	單元三　慢性病與健康關聯（久坐、代謝、飲食與抑制功能）
15:15–16:00	單元四　教案規劃與動作設計（實作：懷舊分析、四大機制、八大動作）
16:00–16:25	單元五　現場應用（分組演練：同一活動三種層次）

16:25–16:30	Q&A・回饋

開場暖身：節奏遊戲

▶ Say the Word on Beat 跟著節拍說出圖片　▶ 節拍遊戲　▶ 節奏挑戰影片清單

0　先認識我們的學員

小作所的「預防及延緩失能」為什麼不一樣？

智能障礙

- 理解抽象指令較慢，**看示範**比聽說明有效
- 老化跡象常比一般人提早出現（體力、記憶、動作速度）
- **唐氏症**者罹患阿茲海默症的風險較高、發病年齡較早；部分有寰樞椎不穩定，避免頸部過度屈曲、翻滾、頭頂地

自閉症

- 喜歡**可預測**的流程，改變需事先預告
- 感覺處理差異：音樂太大聲、身體碰觸、擁擠都可能造成不適
- 固著興趣可以變成**動機的入口**（例如喜歡火車 → 「火車排隊」排序遊戲）

多重障礙

- 可能合併肢體、視聽、癲癇、語言表達困難
- 需要**坐姿版本**與**輔具支持**（扶手、穩定椅、加大道具）
- 參與不一定是「做完全部」，而是做得到的那一段

共同的樣貌：手腳功能大多 OK，但受認知影響，整體出現**體能衰弱（久坐、肌力下降、平衡差）**、**認知退化（反應慢、記不住流程）**與**慢性病（肥胖、三高、便秘、骨質疏鬆）**三方面的退化。
所以小作所的預防及延緩失能，目標不是「練成運動員」，而是**守住並延長「能在作業所工作、能自己生活」的功能**。

核心觀念：復能 ＝ 訓練 ＋ 支持

	復健思維	復能思維
中心	疾病、能力	人、功能（他想做、需要做的事）

問的問題	「腳沒有力氣」	「走不到作業區、不能自己去買午餐」
做法	訓練身體能力	訓練＋支持：輔具 環境 策略 資源 轉念 訓練

活動分析的三個步驟：**發現困難 → 釐清原因 → 處理原因**。同樣是「不參加運動」，可能是聽不懂、怕吵、太難、太簡單、身體痛、或只是不知道什麼時候開始——原因不同，處理方式就不同。

自立支援 ≠ 自己靠自己；自立支援＝在支持下「自主決定生活、不被限制」。

1　核心訓練模組

有氧・肌力・平衡・體智能：先簡化，再逐步加難

建議運動量（WHO 2020 指引，已納入身心障礙者）

- 每週 **150–300 分鐘**中等強度有氧（可分次累積，每一次活動都算數）
- 每週 **2 天以上**肌力訓練；有跌倒風險或年紀較長者，每週 **3 天**多元訓練（平衡＋肌力）
- **減少久坐**，做一點比完全不做好，從做得到的量開始

強度簡易判斷：「講話測試」——可以講話但沒辦法唱歌＝中等強度；講不出完整句子＝太喘，要放慢。

六個萬用「難度旋鈕」

任何活動都可以用以下旋鈕簡化或加難，**一次只轉一個**，學員成功 2–3 次再往上調：

旋鈕	簡化 L1	→	加難 L4
姿勢／支撐	坐姿、雙手扶椅	站姿扶椅 → 單手扶	徒手站、移動中
速度／節奏	慢、自己的速度	固定節拍 80–100 bpm	100–120 bpm 以上、變速
動作複雜度	單一動作、單側	雙側同步	上下肢不同步、交叉、轉向
負荷／量	自身體重、少次數	彈力帶、水瓶	負重、多組、拉長時間
提示量	肢體協助＋示範	示範＋手勢	只給口語或圖卡
認知負荷	不加認知任務	順數、跟著喊	倒數、規則切換、抑制（看到紅色不動）

1-1　有氧訓練

目標：心肺耐力、體重與血糖控制、情緒穩定。小作所最容易融入的是**每天固定時段的音樂律動、走路、超慢跑**。

分級	做法	帶領提示
L1	坐姿踏步、坐姿抬膝、坐姿拍手（60–90 bpm）	先跟著拍手抓節奏，不求對拍
L2	站姿踏步、前抬膝、踏併步、腳跟點（100 bpm）	一個動作做 8 拍×4 次再換

L3	V 字步、曼波、側點步、後勾、超慢跑（100–120 bpm）	兩個步伐組合成「小套路」
L4	交叉步、麻花步、轉身、農夫走路、超慢跑加認知指令	加入方向變化或口令切換

有氧步伐 16 式：踏步、前抬膝、跨步抬膝、踏併步、V 字步、後勾、側／後弓箭步、曼波、恰恰、側點步、開合跳、腳跟點、側／背跨蹲、交叉步、麻花步、扭轉步。節拍原則：60 bpm＝一秒一拍，120 bpm＝一秒兩拍；太難就降到 120 以下，要加難度再往上。

▶ 坐站姿節奏大腦運動 100–120 bpm youtu.be/Yyd5VYJXjw8 ▶ 超慢跑跟跑影片資料庫 ▶ 舞蹈有氧影片資料庫 ▶ 老歌律動 ▶ 長輩律動產生器 ▶ 直線操作形式 reurl.cc/v7yeko

1-2　肌力訓練

目標：守住「站得起來、走得動、搬得動」。**訓練原則：**以「微酸感」為準——**超負荷**（比平常多一點）、**漸進性**（慢慢加）、**特殊性**（練什麼就進步什麼）、**可逆性**（停練就退步）。

復能之王：坐站（Sit to Stand）
一週 3 次，一次分段加總 **100–600 下**（例如每天作業前、午餐前、下班前各做 10 下 × 數組）。它同時練到下肢肌力、平衡、如廁與上下車的功能。
衰弱者四個提升目標：坐的時間　站立時間　坐站次數　走路距離與時間

分級	下肢（坐站）	上肢／軀幹
L1	高椅＋雙手扶扶手站起；或坐姿抬腿、夾球（等長收縮）	坐姿推手、握毛巾擰、壓球
L2	一般椅子、雙手交叉胸前站起	彈力帶划船、推牆
L3	慢慢坐下 3 秒（離心）、矮椅、抱水瓶站起	彈力帶上推、拉開；橋式
L4	徒手深蹲、弓箭步、30 秒坐站計次挑戰	搬運物品走、單腳橋式、鳥狗式

收縮方式由易到難：等長（用力不動）→ 向心（出力抬起）→ 離心（慢慢放下）。

▶ 彈力帶・椅子動作資料庫 ▶ 核心訓練影片資料庫 ▶ 3D 核心訓練資料庫 ▶ 樂齡運動教案資料庫 ▶ 2026 ACSM 阻力訓練新指引

1-3　平衡訓練

目標：預防跌倒、走路更穩。平衡的難度主要來自**支撐面變小、重心移動、視覺減少、加入第二個任務**。

分級	靜態平衡	動態平衡
L1	扶椅雙腳併攏站 10 秒	扶椅左右移重心、坐姿伸手拿物
L2	半前後站（腳跟對腳弓）	交替踏椅（腳尖輕點小凳）、側走
L3	前後一直線站、單腳站（扶）	直線走、跨障礙、繩梯

L4	單腳站＋轉頭／接球	踮腳走、倒退走、走路中轉身拿物

▶ 4 招居家平衡訓練（動作圖解） ▶ 敏捷繩梯教案 reurl.cc/9Gvzy8 ▶ 四色繩梯 reurl.cc/eOeD6W

▶ 方塊踏步體智步伐 reurl.cc/VDzamR

1-4　體智能訓練（Cognicise）

在同一個活動中，**有目的地結合身體動作與認知挑戰**。三種分類：

分類	運動與認知的關係	小作所例子
合併型	必須完成認知任務才能完成動作，**最貼近生活**	依購物單走到對應顏色角錐拿「商品」
附加型	同時進行，認知是額外加上的	踏步時一起數 1–10、念星期
交替型	先運動、再動腦，輪流進行	律動 5 分鐘 → 配對桌遊 5 分鐘

水能載舟，亦能覆舟：負荷要用「**簡單運動 ＋ 主要思考**」或「**簡單思考 ＋ 主要運動**」，不要兩邊都難。對智能障礙學員，建議**先交替型 → 再附加型 → 最後合併型**；動作不穩的學員，先在坐姿做體智。

活動分級排列組合器（研習互動）

▶ 體智共創｜認知運動教案資料庫 ▶ 體智動畫 ▶ 體智動畫產生器 ▶ 反應動作動畫產生器 ▶ 箭頭反應

▶ 數字剪刀石頭布 ▶ 跑步算數 ▶ 節奏數字 ▶ 手指操・節奏體智

▶ Cognicise 參考影片 youtu.be/1zIEGxapySE

2　功能性訓練解析

練的東西，要「搬得回生活」

功能性訓練的定義：以**日常生活與工作所需的動作或思考**為目標，用接近真實情境的方式練習，讓訓練效果能「遷移」到生活中。

功能性連續光譜

孤立型
單一關節、單一肌群
例：坐著抬腿

→

整合型
多關節、多肌群一起
例：坐站、深蹲

→

生活化
放進真實任務
例：蹲下拿箱子放上架

越往右，功能性越高，但對控制與安全的要求也越高。**對衰弱或不理解指令的學員，可以從左邊開始，但目標要指向右邊。**

運動的功能性 vs 認知的功能性

運動的功能性

練的是**生活與工作會用到的動作模式**：走路、深蹲、弓步、延伸、旋轉、抬舉搬運、推拉、跳躍（詳見單元四 b）。

例：作業所的包裝工作要「蹲下拿料 → 起身 → 轉身放到桌上」，就是深蹲＋抬舉＋旋轉的組合。

認知的功能性

練的是**認知在自我照顧與日常活動中的運用**：記得工作步驟、找到物品、照順序完成、看提示做決定、忍住不該做的事。

例：依「備餐圖卡」照順序擺好餐具，比單純玩記憶翻牌更直接用得到。

認知活動的光譜：刺激、訓練、復能、功能性認知

類型	做什麼	例子	限制／提醒
認知刺激	透過五感、聊天、懷舊、團體活動，**廣泛地喚醒**大腦與社會互動	看老照片聊天、聽歌、手作、學習療法（動手、動口、動腦）	容易進行，但**有輸出才有效果**：要讓學員說、做、選
認知訓練	針對特定能力（注意力、記憶力、執行功能）**反覆練習**、逐步加難	舒爾特方格、記憶翻牌、抑制控制遊戲	練了會進步，但**不一定會遷移**到生活
認知復能	以**個人生活目標**為主：本來會做的事、新的角色與學習	重新學會自己搭公車、記得領藥	需要個別化目標與支持策略
功能性認知	把認知機制**嵌入生活任務**：配對、組合、排序、線索	襪子配對、湊出 50 元、洗手步驟排序、照提示找物	小作所最推薦，兼具**訓練與生活意義**

一句話分辨：認知刺激「讓大腦醒來」；認知訓練「讓某項能力變強」；功能性認知「讓能力用在生活裡」。
功能性訓練＝**身體的功能性動作** ＋ **認知的功能性任務**，兩者合併就是最貼近生活的「合併型體智活動」。

▶ 站起來才算數：功能性訓練互動課　▶ WHO 失智風險降低指南整理

3　慢性病與健康關聯

運動、規律飲食、抑制功能，是同一條鎖鏈

為什麼小作所學員更需要動？

- **活動量偏低、久坐時間長**：作業多為坐姿，交通依賴接送。

- **體重與代謝風險高**：部分精神科或抗癲癇用藥可能增加食慾與體重；加上飲食自我控制較困難。
- **常見健康問題**：肥胖、高血壓、糖尿病、高血脂、便秘、骨質疏鬆、睡眠問題、提早老化與失智風險。

久坐傷身的機轉

久坐 → 肌肉中分解脂肪的酵素（LPL）活性下降 → 好膽固醇（HDL）下降、血糖代謝變差 → 慢性低度發炎。

對策：「運動點心」——每 30–60 分鐘起身 1–3 分鐘：站起來坐下 10 次、原地踏步、伸展。研究顯示，打斷久坐就能明顯改善餐後血糖。

慢性發炎與疼痛

肥胖、糖尿病、代謝症候群會造成**代謝性發炎**，讓疼痛更敏感，也讓運動的止痛效果變差。

處理方向：規律運動（肌力＋有氧）、睡眠、紓壓、少精緻糖與加工食品、多蔬果原型食物。核心訊息是：**「動，是安全的」**。

規律飲食：自立支援「三不四要」

三不：不臥床、不包尿布、不約束

四要：每天喝水約 **1500 cc**、每天約 **1500 大卡**、每天運動 **30 分鐘**、**3 天**至少排便一次
（水量、熱量依個人體型與醫囑調整）

運動和飲食是互相支撐的：運動促進腸胃蠕動、改善便秘與食慾調節；**固定時間吃飯、固定時間運動**，讓身體節律與作業所作息一致，也讓學員更有可預測性。

抑制功能：飲食控制背後的大腦能力

執行功能包括：組織計畫、**抑制功能**、認知轉換彈性。
抑制功能＝「忍住不做」的能力：忍住不多拿點心、不搶先、輪到別人時等一下、看到紅燈停下來。
很多學員「知道」不能多吃，卻「做不到」——卡住的常常不是知識，而是抑制功能。

- **練抑制，就是練生活：**紅綠燈遊戲（綠燈走、紅燈停）、「聽到『水果』才拍手」、看到指定顏色不能動。
- **運動本身能幫抑制功能：**規律有氧與體智活動對執行功能有正面影響。
- **環境支持比意志力更有效：**點心分裝成小份、用視覺化餐盤、固定座位與用餐流程、減少零食出現在視線內。

▶ 抑制功能：數值數量干擾　▶ 雙重規則篩選　▶ 交替性認知　▶ 營養標示怎麼看　▶ 食品標籤互動簡報
▶ 慢性病互動教學簡報　▶ 預防肌少症

運動前安全檢核

- ☐ 今天精神與情緒狀況如何？（不舒服就降級或休息）
- ☐ 高血壓學員：運動前量血壓，明顯偏高時先休息、不做憋氣與用力推舉
- ☐ 糖尿病學員：避免空腹運動，準備糖果或果汁
- ☐ 癲癇學員：避免高處、疲勞過度；準備軟墊與安全空間
- ☐ 唐氏症學員：避免頸部過度屈曲、翻滾、頭部撞擊動作
- ☐ 骨質疏鬆、體重過重：跳躍改為墊腳尖或低衝擊版本
- ☐ 場地：地面防滑、椅子穩固（靠牆）、動線淨空、水已準備

4　教案規劃與動作設計

4(a)　認知教案

學習的兩條路：連結已知 × 深度運作

連結已知

從**學員已經知道、本來會做**的經驗出發，用熟悉的記憶、物品、技能來勾連新的內容。

特色：容易參與、情緒安全、成功率高。適合破冰、暖身、能力較弱者。

深度運作

需要**專注思考、加工整理**：比較、分類、排序、推理、說出理由、創造新的東西。

特色：認知負荷較高、訓練效果較強。適合主活動、能力較好者。

懷舊教案的應用分析：同一個主題，兩種深度

提醒：小作所學員的「懷舊」不是長輩的老歌。學員多在 20–50 歲，懷舊素材要用**他們自己的年代與生活**：小時候的卡通、零食、玩具、偶像、學校生活、家人照片、作業所過去的活動照片。

主題	連結已知（容易）	深度運作（加難）
古早零食・柑仔店	看零食照片說出名字、「你吃過嗎？」舉手、摸摸看實物	把零食依價錢排序、用 50 元組合出想買的零食、比較以前和現在的價格
卡通與偶像	聽主題曲前奏猜卡通、跟著唱	依年代把卡通排順序、說出角色的特點、分組編一段新劇情
我的家人	看自己的家庭照片指出「這是誰」	做「我的一天」時間軸：誰陪我做什麼、按時間排好
台灣大事・節日	過年吃什麼？放鞭炮、發紅包的經驗分享	節日卡片依月份排序、配對節日與食物、找出不屬於這個節日的東西

分析步驟：① 選一個學員有共同經驗的主題 → ② 先用「連結已知」暖身、讓每個人都能成功 → ③ 再依能力加入「深度運作」任務 → ④ 回到生活（例如真的去合作社用 50 元買東西）。

▶ 老時代・懷舊活動資料庫　▶ 台灣重要事件互動圖卡　▶ 今昔照片猜猜看　▶ 懷舊童玩資料庫
▶ 流行金曲猜歌　▶ 食物猜猜看　▶ 台語俗諺　▶ 沙包「一放雞」示範　▶ 翁仔標兩種玩法

功能性認知四大機制：配對・組合・排序・線索

機制	定義	生活／工作對應	小作所活動範例與分級	可用工具
配對	尋找相同或相似，**只有一個答案**	襪子成對、餐具歸位、零件分類、找自己的置物櫃	易 顏色相同放一起 難 找「用途相同」的（牙刷↔牙膏）、記憶翻牌	記憶翻牌、找兩張相同、找相同圖案
組合	把元素組起來，**答案有很多種**	湊錢付款、便當配菜、穿搭、包裝組合	易 用 10 元、5 元、1 元湊 20 元 難 九宮格加總相等、用 100 元買 3 樣東西	3×3 數字組合、超市購物計算、百元購物
排序	有**比較**的概念：大小、多少、先後	工作步驟、洗手刷牙順序、一天作息、物品由大到小上架	易 3 張步驟圖卡排順序 難 撲克牌 1–13 排序、依年代排事件	數字排列快手、顏色排序快手、1–13 桌遊
線索	尋找、探索、**發現解答**	找東西、看標示找廁所、依提示完成任務、猜謎	易 看圖片提示找出教室裡的物品 難 三個提示猜一樣東西、尋寶任務卡	找找看、猜動物、思考作答

怎麼搭配？公式：機制 × 素材 × 動作

- **配對 × 水果 × 走路**：拿到水果圖卡，走到同顏色的籃子放進去。
- **排序 × 洗手步驟 × 蹲撿**：地上散落 5 張步驟卡，蹲下撿起並照順序貼到白板。
- **組合 × 錢幣 × 推拉**：用彈力帶拉 1 下得 1 元，湊到便當的價錢就「買到午餐」。
- **線索 × 作業所物品 × 搬運**：依提示卡找到指定箱子，雙手搬到工作檯。

四大機制也可以兩兩合併：先配對分類，再排序；或先看線索找到物品，再組合成套。

▶ 撲克骰子（四大機制）　▶ 撲克隨機　▶ 骰子賓果　▶ 形色牌　▶ 舒爾特方格　▶ 認知手冊生成器
▶ 時鐘練習單

4(b)　動作功能性：八大功能性動作

參考 MAT（Movement Assessment Technologies）的功能性動作分類，並對應小作所學員的生活與工作。對**中重度智能障礙者**，特別推薦：坐站肌力　地面取物　交替踏椅平衡　爬樓梯　低衝擊跳躍（骨密度）。

動作	生活／作業對應	分級 L1 → L4	帶領口訣／安全

深蹲	坐下站起、如廁、上下車	L1 扶手坐站 L2 雙手前伸坐站 L3 扶椅半蹲 L4 徒手深蹲、抱物深蹲	「屁股往後坐、鼻子過腳尖」；膝蓋對準腳尖
弓箭步蹲	上樓梯、跨步、蹲低單膝跪拿東西	L1 扶椅分腿站 L2 扶桌靜態弓步 L3 前跨一步回來 L4 弓步＋轉身傳物	旁邊放椅子或桌子當扶手；步伐不用大
走路	通勤、移動到作業區、購物	L1 陪走、扶走 L2 直線走、側走 L3 跨障礙、上下坡、超慢跑 L4 農夫走路（提重物走）、走路＋認知指令	走路是基本功：安全 → 速度 → 距離 → 強度
軀幹延伸	擦桌、晾衣、高處拿物	L1 坐姿雙手上舉 L2 坐姿前彎摸膝、側彎拿物 L3 站姿延伸摸高處貼紙 L4 單腳站延伸	軀幹要更早訓練；背保持一直線
前後左右旋轉	轉身拿物、傳遞、倒車看後方	L1 坐姿左右轉看人 L2 坐姿左右傳球 L3 站姿轉身傳物 L4 走路中轉身、Pallof 抗旋轉	多方位：前、後、左、右、轉；腳先轉、身體跟著轉
蹲撿／雙手搬運	撿掉落物、搬貨、拿購物籃	L1 坐姿撿椅旁高物 L2 撿椅面上的物品 L3 撿地上的物品 L4 雙手搬箱走一段放上架	用視覺化提示（顏色貼紙標位置）；髖部往後、東西貼近身體
手部推拉	開門、推車、拉抽屜、拖地	L1 坐姿推掌、拉毛巾 L2 推牆 L3 彈力帶划船、上推 L4 推推車、雙人拉繩	軀幹穩定、善用道具；不憋氣，「出力吐氣」
腳部跳躍	骨密度、反應、跨越水溝	L1 坐姿墊腳尖 L2 站姿扶椅墊腳尖 L3 原地小跳 L4 前後左右跳格子	爆發力＝力量×速度；骨鬆、過重、唐氏症頸椎問題者以墊腳尖替代

作業所就是最好的訓練場：把「工作任務」拆成功能性動作來練——搬料（蹲撿＋搬運）、擦桌（延伸＋旋轉）、推回收車（推拉＋走路）、上架（深蹲＋延伸）。學員練得到、也用得到，訓練動機更高。

▶ 功能性訓練衛教動畫 ▶ 彈力帶動作資料庫 ▶ 跟著動作環遊世界 ▶ 痠痛問題影片資料庫

5　現場應用：團體與個別活動規劃

差異這麼大，怎麼帶？

先看「遊戲能力」再分層：從人類發展看活動帶領

感覺動作
摸、拍、丟、聽
破冰・最基礎

→

動作操作
拿、放、傳、疊
入門引導

→

配對分類
找相同、分顏色
多數學員的主活動

→

規則遊戲
輪流、計分、勝負
主活動進階

→

自主複雜

自己決定、帶領別人

小老師角色

同一個團體裡，學員可能分布在不同層級。**活動設計時，要讓每個層級都有事做**，而不是用中間程度「一套帶全部」。

團體活動規劃：同一活動、三種參與層次

範例：「小作所便利商店」60 分鐘

層次	任務	練到什麼
A 補貨員	坐著把商品依顏色放進籃子（配對）；搬一籃走到貨架	感覺動作、配對、搬運、走路
B 顧客	拿 3 張購物圖卡，走到貨架蹲下找到商品（線索＋蹲撿），回來排好	記憶、線索、蹲撿、平衡
C 店員	幫顧客結帳：算總價、用錢幣組合找錢、說「謝謝光臨」	組合、計算、規則、社交

換角色輪流做，A 可以在協助下嘗試 B，C 也要當一次補貨員——角色有成功、有挑戰。

帶領的三部曲與結構化

暖身・喚醒
現實導向（今天日期、天氣）＋ 伸展、節奏遊戲
10 分

→

主體・高峰
具體、動靜態交替、可達成、有意義
35–40 分

→

緩和・降落
讚美、喝水、按摩球放鬆、收心
10 分

結構化（特別是自閉症學員）

- **視覺流程表**：今天做什麼、做完打勾
- **固定開場儀式**與結束訊號（同一首歌）
- 計時器看得見「還剩多久」
- 固定位置、地上貼腳印或顏色標記
- 音樂音量降低，提供「休息角」

五種提示，由少到多或由多到少

1. 口語提示：「我們站起來」
2. 視覺提示：圖卡、顏色標記
3. 手勢提示：指方向、比數字
4. 示範提示：老師做一次
5. 肢體提示：輕扶、引導動作

新動作可以從多提示開始，逐步減少；熟悉的動作先給最少提示，做不到再增加。

溝通魔法：給選擇，不給命令

NG：「你不准坐著！」「快一點！」

OK：「你要用紅色彈力帶還是藍色？」「要先踏步還是先拍手？」「再做 3 下就休息喝水，好不好？」

提供選擇的方式：封閉式 → 邀請式 → 選擇題 → 視覺化（指圖卡選）。讓學員有掌控感，參與度自然提高。

人力與站位

- 主帶領者在前方示範；助理人員站在**需要較多協助的學員旁**或後方。
- 能力好的學員安排為**小老師**，負責發道具、示範、計分。
- 坐姿組與站姿組可同時進行同一首歌，**動作節奏一致、版本不同**。

個別活動規劃：五步驟

① 評估
能力＋興趣＋生活需求

→

② 目標
SMART，指向生活或工作

→

③ 活動分析
拆步驟、找卡關點

→

④ 分級練習
轉難度旋鈕

→

⑤ 紀錄調整
完成／部分完成／未執行

簡易評估	做法	看什麼
30 秒坐站	雙手交叉胸前，30 秒內完整坐站次數	下肢肌力、耐力
單腳站立	左右腳各計秒數（最多 30 秒，旁邊有人保護）	靜態平衡
起立走（TUG）	從椅子站起、走 3 公尺、轉身走回坐下的秒數	行動力、跌倒風險
2 分鐘原地踏步	膝蓋抬到大腿中間高度，計次數	心肺耐力

功能性觀察	做一次實際工作任務（搬一箱、擦一張桌子）	動作模式、步驟順序、需要的提示量

每 3 個月重測一次，用同一張紀錄表追蹤；給學員看自己的進步（貼紙、圖表）也是很好的動機。

三位學員的個別化示範（虛擬個案）

阿明｜34 歲・唐氏症

現況：體重過重、愛吃點心、坐站要扶手。

目標：3 個月內不扶手坐站 10 下。

活動：每天三個時段坐站運動點心；「紅綠燈點心遊戲」練抑制；跳躍改墊腳尖。

小芸｜27 歲・自閉症

現況：肢體能力好，但團體時摀耳、離開座位。

目標：能在團體中完成 20 分鐘律動。

活動：視覺流程表＋耳罩；擔任發道具小老師；喜歡火車 → 「火車排隊」排序遊戲。

阿傑｜45 歲・多重障礙

現況：智能障礙合併左側輕度偏癱，走路慢、易跌。

目標：能自己從座位走到作業區、搬一箱材料。

活動：扶桌弓箭步、交替踏椅、農夫走路（右手提輕物）；坐姿版體智遊戲。

▶ 團康及藝術活動　▶ 團體建立遊戲　▶ 一百種團康遊戲示範 reurl.cc/4g4Kev　▶ 社會參與教案資料庫　▶ 身心障礙支持服務五單元

分組演練（16:00–16:25）

1. 每組選一個**作業所的真實任務**（例如包裝、清潔、午餐準備）。
2. 拆出其中的**功能性動作**（八大動作中的哪幾個）與**功能性認知**（配對、組合、排序、線索）。
3. 設計一個 15 分鐘的團體活動，寫出 A　B　C 三種參與層次。
4. 寫出一個安全提醒、一個給學員的「選擇題」。

資源連結總表

研習後可以繼續使用的工具

運動與體能

▶ 樂齡運動教案資料庫　▶ 彈力帶・椅子動作資料庫　▶ 核心訓練影片資料庫　▶ 3D 核心訓練

▶ 超慢跑跟跑　▶ 舞蹈有氧　▶ 手指操・雙側協調操　▶ 平衡訓練圖解　▶ 功能性訓練互動課

體智能

▶ 體智共創教案資料庫　▶ 體智動畫　▶ 反應動作動畫　▶ 律動產生器　▶ 節拍遊戲

▶ 上下肢動作配對　▶ 體智活動網站

功能性認知與執行功能

▶ 記憶翻牌　▶ 3×3 組合　▶ 數字排序　▶ 找找看　▶ 超市購物計算　▶ 抑制功能

▶ 執行功能密碼轉換　▶ 團體注意力訓練營　▶ 專注力尋寶　▶ 連接方塊 3D 題庫

懷舊與團康

▶ 懷舊活動資料庫　▶ 流行金曲猜歌　▶ 台灣重要事件圖卡　▶ 桌遊 100　▶ 活動 YouTube 資料庫

▶ 日本團康體操影片　▶ 折氣球互動教案　▶ 藝術活動資料庫

健康與慢性病

▶ 慢性病互動教學　▶ 食品標籤這樣看　▶ 預防肌少症　▶ WHO 失智風險指南

參考資料

World Health Organization (2020). WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour.

Herold, F. et al. (2018). Thinking while moving or moving while thinking – concepts of motor-cognitive training for cognitive performance enhancement. *Frontiers in Aging Neuroscience*.

Kawashima, R. 等（2003）學習療法：讀寫與計算對認知功能之研究。

Livingston, G. et al. (2024). Dementia prevention, intervention, and care: 2024 report of the Lancet standing Commission.

Movement Assessment Technologies (MAT) 功能性動作分類；島田裕之《體智活動》相關著作。

愛迪樂｜鍾孟修 職能治療師　愛迪樂健康促進團隊

個人臉書　｜　愛迪樂粉絲專頁

本講義供伊甸汐止小作所研習使用；個案為教學用虛擬案例。運動前請依學員健康狀況與醫囑調整。